

OLHO VERMELHO E EDEMA — PRÉ ou PÓS-SEPTAL?

PRÉ-SEPTAL vs ORBITÁRIA (PÓS-SEPTAL)

Achado	Pré-septal	Orbitária (pós-septal)
Local	Anterior ao septo orbitário (pálpebra)	Posterior ao septo (conteúdo orbitário)
Edema/eritema palpebral	Presente	Presente
Proptose	AUSENTE	PRESENTE (sinal-chave)
Dor à motilidade ocular	Ausente	PRESENTE; oftalmoplegia (limitação)
Acuidade visual	Normal	Pode estar REDUZIDA (sinal de gravidade)
Gravidade	Geralmente benigna	EMERGÊNCIA: risco de abscesso, trombose de seio cavernoso, cegueira

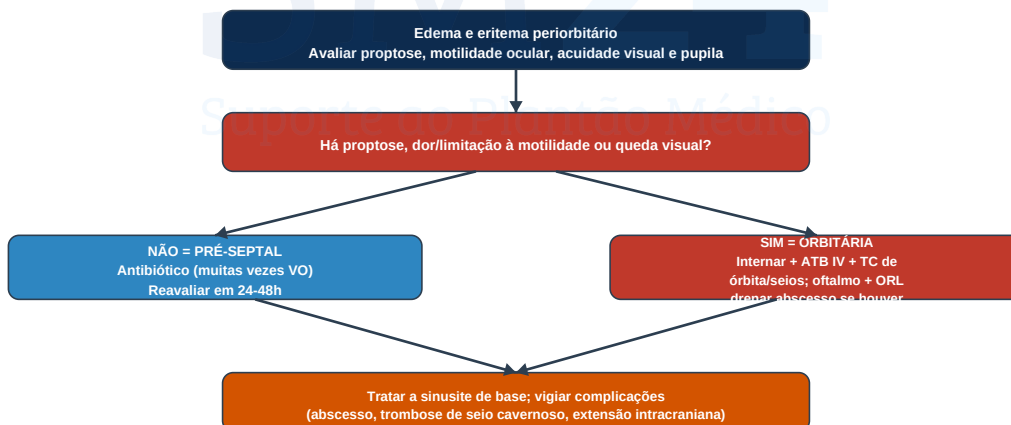
OS SINAIS QUE INDICAM ORBITÁRIA (PÓS-SEPTAL)

PROPTOSE, DOR/LIMITAÇÃO À MOTILIDADE E QUEDA VISUAL = EMERGÊNCIA

- Proptose (exoftalmia), dor à movimentação ocular, oftalmoplegia, queda da acuidade visual e alteração da visão de cores ou do reflexo pupilar = celulite ORBITÁRIA
- Causa mais comum: extensão de SINUSITE (sobretudo etmoidal) — frequente em crianças
- Complicações: abscesso subperiosteal/orbitário, trombose de seio cavernoso, perda visual, extensão intracraniana
- Conduta: internação + antibiótico IV de amplo espectro + TC de órbita e seios paranasais
- Avaliação oftalmológica e otorrinolaringológica urgente; drenagem cirúrgica do abscesso se presente
- A pré-septal, sem esses sinais, costuma ser tratada com antibiótico (muitas vezes ambulatorial), com reavaliação

ABORDAGEM

EDEMA PALPEBRAL -> HÁ SINAL PÓS-SEPTAL?



ETIOLOGIA E TRATAMENTO

Aspecto	Detalhe
Agentes	S. aureus (incluindo MRSA), Streptococcus, H. influenzae; sinusite associada na orbitária
Pré-septal (origem)	Trauma/picada/lesão de pele palpebral, hordéolo, dacriocistite, conjuntivite
Orbitária (origem)	Sinusite (etmoidal) na maioria; extensão de infecção dentária/facial
ATB pré-septal	Amoxicilina-clavulanato (ou cobertura para MRSA conforme risco); reavaliar
ATB orbitária	IV de amplo espectro (ex.: ceftriaxona + cobertura para S. aureus/MRSA + anaeróbios conforme caso)
Imagem	TC de órbita e seios paranasais com contraste na suspeita de orbitária/abscesso

COMPLICAÇÕES E CUIDADOS

Sinais de Alarme / Complicações

- Queda da acuidade visual ou alteração do reflexo pupilar (defeito aferente)
- Oftalmoplegia dolorosa e proptose progressiva
- Abscesso subperiosteal/orbitário (TC)
- Trombose de seio cavernoso: acometimento bilateral, paralisia de pares cranianos, toxemia
- Cefaleia intensa, rebaixamento (extensão intracraniana)
- Febre alta e toxemia

Conduta na Orbitária

- Internação e antibiótico IV de amplo espectro precoce
- TC de órbita e seios paranasais com contraste
- Avaliação oftalmológica e otorrinolaringológica urgentes
- Drenagem cirúrgica do abscesso / dos seios quando indicado
- Monitorar a acuidade visual e a motilidade seriadamente
- Tratar a sinusite de base

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Avaliar proptose, dor/limitação à motilidade ocular, acuidade visual e pupila em todo edema periorbitário
- ☐ Pré-septal (sem esses sinais): antibiótico, frequentemente ambulatorial, com reavaliação
- ☐ Orbitária (proptose/oftalmoplegia/queda visual): EMERGÊNCIA
- ☐ Orbitária: internar + ATB IV + TC de órbita/seios + oftalmo e ORL urgentes
- ☐ Drenar abscesso quando presente; tratar a sinusite de base
- ☐ Vigiar complicações: abscesso, trombose de seio cavernoso, perda visual, extensão intracraniana

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Criança com edema palpebral, proptose, dor à movimentação ocular e queda da acuidade visual. Qual o diagnóstico e a conduta?

- A) Celulite pré-septal — antibiótico oral e alta
- B) Celulite orbitária (pós-septal) — internação, antibiótico IV e TC de órbita/seios, com oftalmo e ORL
- C) Conjuntivite — colírio antibiótico
- D) Hordéolo — compressas mornas
- E) Alergia — anti-histamínico

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado diferencia a celulite orbitária da pré-septal?

- A) Edema palpebral
- B) Proptose, dor à motilidade ocular e/ou queda da acuidade visual
- C) Eritema da pálpebra
- D) Febre baixa
- E) Secreção conjuntival

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual é a causa mais comum de celulite orbitária, especialmente em crianças?

- A) Conjuntivite
- B) Extensão de sinusite (sobretudo etmoidal)
- C) Trauma palpebral
- D) Hordéolo
- E) Dacriocistite

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual exame de imagem é indicado na suspeita de celulite orbitária/abscesso?

- A) Radiografia simples de crânio
- B) TC de órbita e seios paranasais com contraste
- C) Ultrassonografia abdominal
- D) Eletroencefalograma
- E) Cintilografia

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual complicação grave deve ser temida na celulite orbitária?

- A) Conjuntivite alérgica
- B) Trombose de seio cavernoso e perda visual
- C) Catarata
- D) Glaucoma crônico
- E) Pterígio

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Proptose + dor à motilidade ocular + queda da acuidade visual indicam celulite ORBITÁRIA (pós-septal), uma emergência. Conduta: internação, antibiótico IV de amplo espectro, TC de órbita e seios paranasais e avaliação urgente de oftalmologia e otorrinolaringologia.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A celulite orbitária se diferencia da pré-septal pela presença de proptose, dor/limitação à motilidade ocular (oftalmoplegia) e/ou queda da acuidade visual — sinais de acometimento do conteúdo orbitário (posterior ao septo).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A causa mais comum de celulite orbitária é a extensão de uma sinusite, particularmente a etmoidal (separada da órbita por uma lâmina óssea fina), especialmente em crianças.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A TC de órbita e seios paranasais com contraste é o exame indicado na suspeita de celulite orbitária — avalia a extensão pós-septal, identifica abscesso subperiosteal/orbitário e a sinusite de base.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A celulite orbitária pode evoluir com complicações graves como trombose de seio cavernoso, abscesso, perda visual e extensão intracraniana — por isso é uma emergência que exige tratamento e investigação imediatos.

SM24
Suporte ao Plantão Médico